PANCRÉAS · PA-01

# Kystes du pancréas · TIPMP (Kyoto 2024)

**Kyoto 2024 (IAP)**
stigmates de haut risque, signes inquiétants, surveillance

**Définitions :** **TIPMP des canaux secondaires** : kyste > 5 mm communiquant avec le canal pancréatique principal (CPP) · **TIPMP du canal principal** : dilatation segmentaire ou diffuse du CPP **> 5 mm** sans autre cause d'obstruction · **mixte** : les deux. Éliminer un pseudokyste si antécédent de pancréatite ou de traumatisme. Imagerie de référence : **IRM avec cholangio-pancréato-IRM** ; scanner et écho-endoscopie si modification.

## CRITÈRES DE RISQUE · KYOTO 2024

**Stigmates de haut risque → chirurgie si opérable**

- Ictère obstructif avec kyste de la tête du pancréas
- **Nodule mural rehaussé ≥ 5 mm** ou composante solide
- **CPP ≥ 10 mm**
- Cytologie suspecte ou positive (dysplasie de haut grade ou adénocarcinome)

**Signes inquiétants → écho-endoscopie ± ponction**

- Pancréatite aiguë ; CA 19-9 > 37 U/mL ; diabète récent ou aggravé dans l'année
- **Kyste ≥ 30 mm**
- **Nodule mural rehaussé < 5 mm** ; paroi épaissie ou rehaussée
- **CPP 5–9 mm**
- Changement brutal de calibre du CPP avec atrophie d'aval
- Adénopathie
- **Croissance ≥ 2,5 mm/an**

Taille du nodule mural : hauteur en écho-endoscopie, plus grand diamètre au scanner ou en IRM. Signes inquiétants confirmés en écho-endoscopie (nodule, atteinte du CPP, cytologie) : discussion chirurgicale en RCP.

## SURVEILLANCE D'UNE TIPMP NON OPÉRÉE (SANS SIGNE DE RISQUE)

| TAILLE DU KYSTE | RYTHME | ARRÊT POSSIBLE |
|---|---|---|
| **< 20 mm** | Contrôle à **6 mois** une fois, puis **tous les 18 mois** si stable | Après **5 ans** sans modification ni signe inquiétant, selon l'état général et l'espérance de vie |
| **20–29 mm** | Contrôle à 6 mois **deux fois**, puis **tous les 12 mois** si stable | Non systématique |
| **≥ 30 mm** | **Tous les 6 mois** | Non |

Arrêter la surveillance si le patient n'est pas opérable ou si l'espérance de vie est < 10 ans. Prudence chez le sujet jeune ou en cas de risque familial ou génétique. Kystes ≤ 5 mm : prise en charge non consensuelle, surveillance pour l'instant.

## ORIENTER LE DIAGNOSTIC DE KYSTE

| KYSTE | ARGUMENTS D'IMAGERIE |
|---|---|
| **TIPMP** | Communication avec le CPP, kystes en grappe, souvent multiples |
| **Cystadénome séreux** | Microkystique en « nid d'abeille », cicatrice centrale ± calcifiée, pas de communication |
| **Cystadénome mucineux** | Femme, corps ou queue, macrokyste avec cloisons, calcifications périphériques |
| **Tumeur pseudopapillaire et solide** | Femme jeune, masse mixte solide et kystique, composante hémorragique |
| **Pseudokyste** | Antécédent de pancréatite, paroi fine rehaussée, débris |

## COMPTE RENDU

**Kyste**
siège, taille, communication avec le CPP, nombre

**CPP**
calibre maximal en mm, changement de calibre

**Risque**
nodule (taille, rehaussement), paroi, stigmates et signes inquiétants

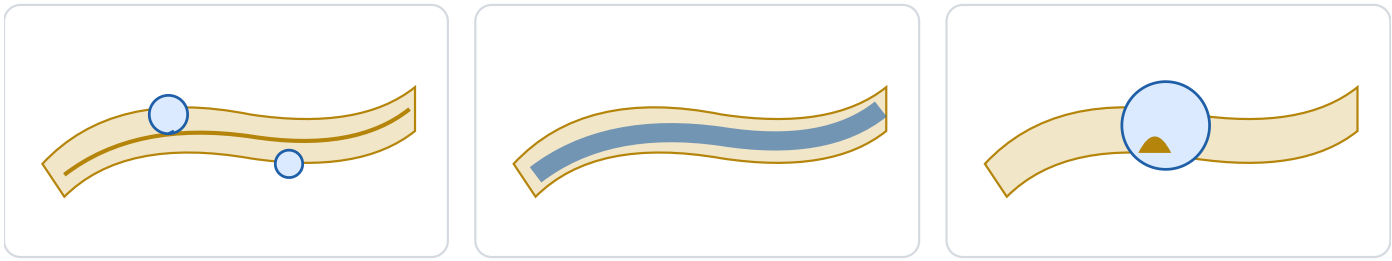
**Évolution**
croissance en mm/an par rapport aux examens antérieurs

# Kystes du pancréas · TIPMP (Kyoto 2024) (suite)



## ATLAS VISUEL

### Types de TIPMP et signe de haut risque



**Canaux secondaires**
kystes communiquant avec le CPP

**Canal principal**
CPP > 5 mm · ≥ 10 mm = haut risque

**Nodule mural**
≥ 5 mm rehaussé = haut risque

Schémas simplifiés, non à l'échelle · CPP = canal pancréatique principal

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**TIPMP**
Radiopaedia · types et signes
radiopaedia.org/articles/intraductal-papillary-m

**Recommandations de Kyoto**
Radiopaedia · synthèse
radiopaedia.org/articles/kyoto-guidelines-intrad

**Cystadénome séreux**
Radiopaedia · aspect microkystique
radiopaedia.org/articles/serous-cystadenoma-of-t

**Néoplasme kystique mucineux**
Radiopaedia · macrokystes
radiopaedia.org/articles/mucinous-cystic-neoplas

**Sources :** International evidence-based Kyoto guidelines 2024 – www.ahpba.org/wp-content/uploads/2025/02/Kyoto-IPMN-Guidelin...